

Interprofessionaalne meeskonnatöö: uus teema sotsiaaltöö praktikas ja uurimustes



Koidu Saia

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, doktorant

Teenusekasutajate probleemide lahendamine, inimeste heaolu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine nõuavad sageli oskusi ja teadmisi mitmelt erialalt (IFSW 2014, Kutsekoda 2014). Seetõttu on interprofessionaalne (IP) praktika eri valdkondade esindajate, sh sotsiaaltöötajate hulgas üha aktuaalsem. Artiklisse on koondatud teaduskirjandusel põhinev ülevaade interprofessionaalsust toetavatest suundumustest, võtmemoistetest ja elementidest ning selle tulemuslikkust mõjutavatest teguritest¹. Võib tõdeda, et täna käsitletakse interprofessionaalset praktikat veel suuresti tervishoius, kuid seda on hakatud kasutama ja analüüsima ka teistes valdkondades ning tasapisi on see levinud Suurbritanniast, Ameerikast, Kanadast ja Põhjamaadest väljapoole.

Interprofessionaalsuse levikut hoogustavad arengud

Mitmesugused suundumused sotsiaaltöös toetavad IP praktika arengut. Teenuse osutamise kvaliteedi ja teenusekasutajate turvalisuse huvides on vaja tõhusat koostööd ja kommunikatsiooni, mis on IP meeskonnatöö lahutamatu komponent. **Kliendi- ja patsiendikeskus** tähendab teenuseosutajate jagatud kontrolli ja sõnaõigust sekkumisi puudutavate otsuste langetamisel ning tähe-

lepanu pööramist inimesele kui tervikule (Lewin jt 2001). Eri valdkondade spetsialistid töötavad koos, asetades keskmesse teenusekasutaja, et tagada ja suurendada teenuse osutamise kvaliteeti (Dean 2008). Kliendi- ja patsiendikeskset meeskonnatööd peetakse toimivaks meetodiks nii ennetuses (*ibid*) kui ka tervenemis- ja taastumisperioodil (Edwards 2002). Teenusekasutaja ja tema lähedaste kaasamine toetab sekkumiste tulemuslikkust, kuid see eeldab spetsialistidelt ja

¹ Interprofessionaalse meeskonnatöö praktikast Eestis saab lugeda ajakirjas *European Journal of Social Work* ilmunud artiklist (Saia jt 2017).

ka teenusekasutajatelt oskust teha koostööd ning kontrolli ja võimu jagamisega toime tulla.

Üha enam sekkumisi on kompleksed ja terviseprobleemide puhul pigem pikaajalised (WHO 2005). See eeldab teenuste paremat lõimitust. Teenusekasutajate suurem teadlikkus, jõustatus ja vastutus seostub nn tarbijaliku kultuuri levikuga sotsiaal- ja tervishoiusektoris (Newman ja Vidler 2006). Koordineeritud meeskonnapõhine teenuste pakkumine vähendab teenuste dubleerimist, suurendab nende tõhusust ja **optimeerib kulusid** (McPherson jt 2001, Zwarenstein jt 2009).

IP teenuseosutamine on üha suurema tähelepanu all **maakogukondades ja äärealadel**, kus teenuseosutajatelt oodatakse laiemat erialast profiili (Hooker ja McCaig 2001), mis aga muudab spetsialistide palkamise keeruliseks (Grobler jt 2009). See loob soodsa pinnase pingeteks eri valdkondade spetsialistide vahel (Booth ja Hewison 2002).

Aina levinum on IP tööks vajalike teadmiste ja oskuste lülitamine õppekavadesse ja kutseandmistingimustesse, need kajastuvad ka kutseorganisatsioonide seisukohtades ja põhimõtetes. IP meeskonnatöö eeldab spetsialistidelt spetsiifilisi hoiakuid, teadmisi ja oskusi (Barr jt 2005, Reeves jt 2008). Üliõpilastele ja spetsialistidele pakutakse **tasemeõppe ja täienduskoolituskavade**, moodulite ja töötubadena võimalusi õppida tundma põhimõtteid ja omandada oskusi, mis aitavad IP meeskonnas edukalt toime tulla (Barr jt 2005). Vajadust koostöö järele teadvustatakse järjest enam nii tervishoius, sotsiaaltöös kui ka teistes valdkondades (WHO 2010). Interprofessionaalne haridus ja praktika on viimase 15 aasta jooksul hakanud üha enam huvi pakkuma ka teadlastele, kuna koos töötamine eeldab ka koos õppimist (Baldwin 1996). Koos õppimine ei

toeta üksnes ühist töötamist, vaid aitab ka praktikutel paremini kohaneda muutuvate nõudmistega, olla paindlikum ja mobiilsem (Barr jt 2011, 5). Töötatakse välja meetodeid, mille abil meeskonnatööd ja koostööd **mõõta ja hinnata** (Reeves jt 2009).

IP meeskonnatöö levikut soodustavad ka teenuste rahastuspõhimõtted, mis eeldavad IP meeskonnapõhiste programmide, kursuste, algatuste ja sekkumiste väljatöötamist, rakendamist ja hindamist.

Viimane kümnend on olnud soodne IP meeskonnatööd, koostööd ja haridust arendavate **organisatsioonide ning võrgustike** tekkeks ja arenemiseks. Näiteks on IP meeskonnatöö edendamisesse jõuliselt panustanud Center for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE), European Interprofessional Education Network (EIPEN), Nordic Interprofessional Network (NIPNET), Australian Interprofessional Practice and Education Network (AIPPEN), The Journal of Interprofessional Care.

Infotehnoloogia tänapäevased võimalused ja lahendused toetavad samuti uute meeskonnatöö vormide arendamist (Reeves ja Freeth 2003, 81) ning mõjutavad IP koostöövormide loomist (Careau jt 2008). Vajadus kasutada üha komplekssemaid tehnoloogiaid ja protseduure suunab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste kitsamale spetsialiseerumisele, teenuste osutamisel suureneb aga vajadus IP meeskonnatöö järele (Cadell jt 2007). Spetsialistide rollid üha muutuvad ning uued viisid interaktiivseks koostööks vajavad arendamist ja katsetamist.

Meeskondade tüübid

Meeskonda võib määratleda kui koos toimivat gruppi, mis on ellu kutsutud selleks, et täita ülesandeid, mida individuaalselt kas üldse või nii hästi teha ei ole võimalik (Douglas 2000). Eristatakse gruppi ja mees-

konda. Meeskonna põhielementidena tuuakse välja järgmisi omadusi (Sundstrom jt 1990): (1) selle liikmetel on jagatud identiteet, (2) igal liikmel on oma roll, mida ülejäänutel ei ole, (3) liikmed on kokku leppinud, kuidas koos töötatakse. Lisaks peab iga meeskonnaliige teadma ja mõistma teiste liikmete rolle ja funktsioone ning silmas pidama ühist eesmärki; meeskonnaliikmed koondivad meeskonda oma teadmised ja oskused; meeskonnaliikmed peavad olema võimelised töötama koos, seejuures üksteisest sõltuvuses olles (Pritchard 1995). Oluline on üksteist austav töökeskkond, vastutuse jagamine, autoriteedi selgus, omavahel kokku lepitud otsustamis- ja kommunikatsiooniprotsess ning regulaarne infojagamine (Headrick jt 1998).

Meeskondade liigitusi on mitmeid, näiteks Drinka ja Clark (2000) pakuvad välja järgmise jaotuse:

- 1) *ad hoc* ehk kindla juhtumiga seotud ülesannete lahendamise multidistsiplinaarsed grupid
- 2) formaalsed multidistsiplinaarsed meeskonnad
- 3) interaktiivsed interdistsiplinaarsed meeskonnad.

Jelphs ja Dickinson (2008) liigitavad meeskondi lähtudes sellest, kui võrd tihedat koostööd teevad erineva taustaga meeskonnaliikmed:

- 1) multidistsiplinaarsed meeskonnad (spetsialistid töötavad külj-külje kõrval, kuid suhtlevad vähe)
- 2) interdistsiplinaarsed meeskonnad (praktikud töötavad koos interaktiivselt ehk tihedas omavahelises koostöös)
- 3) transdistsiplinaarsed meeskonnad (meeskonnatöö kõrgeim tase, kus erineva erialase taustaga meeskonnaliikmete töö integreeritakse).

Need tüpoloogiad on küllaltki üldistavad, praktikas on IP meeskonnatöö sageli kompleksne ja erinevate tüüpide elemente kombineeritakse.

Erinevalt eelnevatest jaotustest ei käsitle võimalustekeskne lähenemine (ingl *contin-gency approach*) meeskondi ega meeskonnatööd lineaarsena, skaalal nõrgast tugevani. Meeskonnatööd kujutatakse kompleksse ja nüansirikka tegevusena, mille raames meeskonnad seavad endale eesmärgid, lähtudes konkreetsetest vajadustest. IP töös eristatakse järgmisi vorme:

- 1) meeskonnatöö (ingl *teamwork*): jagatud meeskonnaidentiteet, selgus, vastastikune sõltuvus, integreeritus, jagatud vastutus ja ülesanded (mis on sageli ennustamatud, kiired, kompleksed) (Piquette jt 2009)
- 2) koostöö (ingl *collaboration*): IP töö nõrgem vorm, kuna jagatud identiteet ja osalejate integreeritus on vähem tähtis (Delva ja Jamieson 2008)
- 3) koordineerimine (ingl *coordination*): jagatakse meeskonnaidentiteeti, kuid osaliste integreeritus ja vastastikune sõltuvus on vähem olulised ja ülesanded on ennustatavamad kui koostöö puhul (Gittell jt 2000)
- 4) võrgustikutöö (ingl *networking*): jagatud meeskonnaidentiteet, rollide ja eesmärkide selgus, vastastikune sõltuvus, integreeritus ning vastutuse jagamine on vähem tähtis (Overtveit 1997, 271).

Teaduskirjanduses kasutatakse mõis-teid *interprofessionaalne meeskonnatöö* ja *interprofessionaalne koostöö* sageli samas tähenduses. Käesolevas artiklis pean IP meeskonnatöö all silmas spetsiifilist töö tüüpi, täpsemalt tegevust, millele on omased selged meeskonna eesmärgid, meeskonna jagatud identiteet, pühendumus, rollide selgus, vastastikune sõltuvus, meeskonnaliikmete vaheline integratsioon (Onyett 2003,

Jelphs ja Dickinson 2008), demokraatlik lähenemisviis, püüe murda stereotüüpe ja barjääre, kindel aeg meeskonnatöö arendamiseks, hea kommunikatsioon, ühine töötamise koht, vastastikune rollide mõistmine, ühised protokollid, koolitus ja tööpraktikad, kokkulepitud professionide piire ületavad praktika prioriteedid, regulaarselt toimuvad meeskonna kohtumised, üksteist väärtustavad ja austavad meeskonnaliikmed ning toimiv töökorraldus (West ja Slater 1996).

Mis mõjutab IP meeskonnatööd

Sarnase tähendusega terminite paljusust tekitab segadus, kuna interdistsiplinaarsuse kõrval räägitakse multidistsiplinaarsusest ja -professionaalsusest, transprofessionaalsusest jne. Teisest küljest on IP meeskonnatöö sisu ja olemus kompleksne (Reeves jt 2009).

IP meeskonnatööd mõjutavaid tegureid on lihtsam vaadelda eri tasanditel seoses suhete, protsessi, organisatsiooni ja kontekstiga (Reeves jt 2010). **Suhetega** seostuvad professionaalne võim, hierarhia ja sotsialiseerumine. Professionaalne sotsialiseerumine on protsess, mille kaudu inividid omandavad normid, väärtused ja hoiakud seoses kindla professionaalse grupiga ning mille tulemusena kujunevad keelekasutus ja käitumisviisid, mis on omased grupile ja professioni kogenumatele liikmetele (Clark 1997), kujuneb professionaalne identiteet (Sinclair 1997) ja lojaalsus oma professionile (Blane 1991). Meeskonna koosseis mõjutab seda, kuidas meeskond funktsioneerib (Reeves jt 2006), tõhusaks IP meeskonnatöök on oluline rollide selgus ja jaotus (West ja Markiewicz 2004). Võtmeroll on juhil, kes mõjutab liikmeid oma võimekuse kaudu motiveerida, otsustada ja julgustada innovatsiooni (Cook 2003). **Protsessi** tasandil mõjutab meeskonnatööd

meeskonna loomise kulg, vastastikune suhtlemine ja usaldus, konfliktide lahendamise viisid, liikmete motiveeritus ja oskused IP töötamiseks, ajaressurss, rutiinid ja rituaalid, infotehnoloogia kasutamise võimalused, toimetulek probleemide ennustamatuse ja kompleksusega, ülesannete delegerimise edukus (Reeves jt 2010). **Organisatsiooni** tasandil on olulisemad tegurid üldine organisatoorne toetus, professionaalne esindatus, kaebuste esitamise võimalus ja kulg. **Kontekstuaalsete** mõjutajatena tuleb tähelepanu pöörata meeskonna kultuurile ja mitmekesisusele, soolisele tasakaalule, poliitilistele (nt kas rahastussüsteem IP meeskonnatööd toetab või mitte) ja majanduslikele mõjudele (nt kulude optimeerimise kriitiline tähtsus, kasumile orienteeritus jne) (*ibid*).

Interprofessionaalseid sekkumisi meeskonnatöös praktikas

IP meeskonnatöö sekkumisi võime Reevesi, Goldmani ja nende kaasautorite järgi (Reeves jt 2009, Goldman jt 2009) jaotada hariduslikeks, praktika- ja organisatsioonipõhisteks. Valik sekkumiste kirjeldusi ja näiteid on toodud tabelis 1.

Kokkuvõtteks

Interprofessionaalne praktika ja haridus on tervishoius tähelepanu pälvinud juba paarkümmend aastat ning on jõudsalt laienemas teistesse valdkondadesse. Teadlikkus interprofessionaalse praktika ja hariduse olemusest ning võtmekompetentside arendamine taseme- ja täienduskoolituste kaudu on eriala eksistentsi mõttes üha olulisem ka sotsiaaltöötajate jaoks. Ilma valmiduse, võimekuse ja oskusteta teiste professionide esindajatega tõhusalt meeskonnana töötada inimeste heaolu ja toimetuleku toetamise

Tabel 1. Näiteid IP meeskonnatöö sekkumistest

Sekkumise tüüp	Näited
IP õppimine: meeskonnatöö koolitus	Interaktiivsed töötoad, õppesessioonid, kus üliõpilased ja/või spetsialistid arutavad meeskonna koostöö võimalusi ja probleemilahendusi. Tavaliselt kombineeritakse õpet klassiruumis praktikapõhise õppega, et valmistada tudengeid ette meeskonnatöoks (Reeves jt 2006). Et pakkuda teenusesaaja perspektiivi, kaasatakse ka teenusesaajaid ja nende peresid (Weingart jt 2009).
Kommunikatsiooniga seotud sekkumised: IP meeskonna kohtumised	IP meeskonna regulaarsed kohtumised suurendavad teadlikkust ja mõistmist meeskonna liikmete rollidest, vastutusest ja jagatud eesmärkidest (Aston jt 2005)
Protseduurilised sekkumised: integreeritud IP sekkumisplaanid, juhtumikorraldus	Integreeritud sekkumisplaanides (ingl <i>integrated care pathways</i>) kirjeldatakse optimaalset sekkumiste sagedust ja ajastust kindlate probleemidega, diagnoosi või sümptomitega teenusekasutajate puhul (Ignatavičius ja Hausman 1995, Leathard 2003a,b). Juhtumikorraldus: sekkumine, mille puhul ühe elukutse esindaja, kes on selleks spetsiaalselt koolitatud, koordineerib teenuste osutamist, sh erineva spetsialistide koostööd. Tegemist on hea näitega IP meeskonnatöö kaudsest sekkumisest (Reeves jt 2010, 97).
Organisatoorsed sekkumised: IP meeskonnatöö kvaliteediarendus, akrediteerimine, teenuste osutamise ümberkorraldamine	Kvaliteediarendus – töökeskkonna, toodete või teenuste kvaliteedi parendamine. Näiteks TQM (<i>total quality management</i>), CQI (<i>continuous quality improvement</i>), PDSA (<i>plan, do, study, act circle</i>). Akrediteerimine – kvaliteedi arendamise viis, mille järgi akrediteeriv organisatsioon tunnustab organisatsiooni kindlatele standarditele vastavaks.
Kontekstuaalsed sekkumised: IP toetavad poliitilised initsiatiivid, rahastusmuutused	Riigi poliitika ja erialaorganisatsioonide poliitikad on mõjutanud oluliselt IP meeskonnatöö arengut mitmes riigis. Näiteks soovitud IP taseme- ja täienduskoolitusprogrammide arendamiseks on toonud kaasa arendused haridusvaldkonnas (Barr jt 2005). Suurbritannias ja Kanadas on rahastajate nõudmisel ellu viidud arendused ja IP meeskonnatöö hindamine.
Mitmekülgsed IP meeskonnatööd tugevdavad sekkumised	Sellised sekkumised tegelevad individuaalsete ja professionipõhiste tegevuste arendamise kõrval komplekssete IP arendustega. Näiteks Freidman ja Berger (2004) kirjeldavad IP meeskonna sekkumisi, mis sisaldavad koolitust meeskonnaliikmete rollide mõtestamiseks, meeskonnaliikmete igapäevaseid töökohtumisi ja IP meeskonnatöö arutamiseks mõeldud igakuiseid kogu meeskonna kohtumisi.

ALLIKAS: REEVES JT 2009, GOLDMAN JT 2009 JÄRGI KOOSTANUD AUTOR

nimel on raske ette kujutada oma tööga hästi toime tulevat sotsiaaltöötajat. Võib eeldada, et juba lähiajal leiavad interprofessionaalne praktika ja haridus sügavamalt käsitlemist nii teadusasutustes, kutsestandardite, õppekavaarenduste kui erialaühenduste tegevuse

raames. Teaduskirjandust ja näiteid headest uurimustest on juba rohkesti. Kuna sotsiaaltöoga seotud IP meeskonnatöö on suhteliselt uus uurimisteema ka välismaa uurijate jaoks, siis ei ole me Eestis IP meeskonnatöö arendamise ja analüüsimisega väga hiljaks jäänud.

Üheks sellesuunaliseks algatuseks on Tallinna Ülikooli uurimisprojekt¹, mille üheks uurimisobjektiks on ülikooli uus õppeaine „Erialasid loimiv uuendus”².

Lõpetuseks lühiküsimustik, mille abil saab iga spetsialist hinnata oma valmidust interprofessionaalseks meeskonnatööks (Hammick ja Freeth 2015, 36 järgi). Kui spetsialist kinnitab, et esitatud väited kehtivad ka tema puhul, siis tal on head eeldused IP meeskonnas töötamiseks.

1. Eelistan töötada osapooli kaasavalt.

2. Oskan töötada teenusekasutajate heaks koos teiste valdkondade kolleegidega.

3. Väärtustan järgmisi omadusi: austus enda, kolleegide ja teenusekasutajate vastu; usaldus; kaasamine; valmidus läbi rääkida ja valmidus jagada.

4. Annan oma mõtted edasi selgelt ja kuulan ning arvestan kolleegide ja teenusekasutajate arusaamu.

5. Pean oluliseks rakendada põhimõtteid ja tegevusi nii, nagu on kolleegide ja teenusekasutajatega kokku lepitud. **S**

Viidatud allikad

- Aston, J., Shi, E., Bullock, H., Galway, R., Crisp, J. (2005). Qualitative evaluation of regular morning meetings aimed at improving interdisciplinary communication and patient outcomes. *International Journal of Nursing Practice*, 11, 206–213.
- Baldwin, D. C. (1996). Some historical notes on interdisciplinary and interprofessional education and practice in health care in the USA. *Journal of Interprofessional Care*, vol 10, 173–187.
- Barr, H., Helme, M., D’Avray, L. (2011). Developing interprofessional education in health and social care courses in the United Kingdom, London: Higher Education Academy.
- Barr, H., Koppel, I., Reeves, S., Hammick, M., Freeth, D. (2005). *Effective Interprofessional Education: Assumption, Argument and Evidence*. London: Blackwell.
- Blane, D. (1991). Health professions. Teoses: Schambler, G. (toim.) *Sociology as Applied to Medicine*. London: Bailliere Tindall.
- Booth, J., Hewinson, A. (2002). Role overlap between occupational therapy and physiotherapy during inpatient stroke rehabilitation: and exploratory study. *Journal of Interprofessional Care*, 16, 31–41.
- Cadell, S., Bosma, H., Johnston, M., Portfield, P., Cline, L., Dasilva, J., Fraser, J., Boston, P. (2007). Practicing interprofessional teamwork from the first day of class: a model for an interprofessional palliative care course. *Journal of Palliative Care*, 23, 273–279.
- Careau, E., Vincent, C., Noreau, L. (2008). Assessing interprofessional teamwork in a video-conference based tele-rehabilitation setting. *Journal of Telemedicine & Telecare*, 14, 427–434.
- Clark, P. (1997). Values in health care professional socialization: implications for geriatric education in interdisciplinary teamwork. *The Gerontologist*, 37, 441–451.
- Cook, M. (2003). *Interprofessional post-qualifying education: team leadership*. Teoses: Glen, S., Leiba, T. (toim.) *Interprofessional Post-qualifying Education for Nurses*. Palgrave, Basingstoke.
- Dean, S. (2008). The Importance of Teamwork in Health Care Teams. www.upiu.com/articles/176 (02.06.2017).
- Delva, D., Jamieson, M. (2008). *High Performance Teams in Primary Care: The Basis of Interdisciplinary Collaborative Care*.
- Douglas, T. (2000). *Basic Groupwork*. London: Routledge.

¹ Projekt „Õppimine ja õpetamine Tallinna Ülikooli üliõpilaste kogemustes ja õppejõudude õpetamispraktikates”, vt lähemalt www.etis.ee/Portal/Projects/Display/3de26eec-83fd-4d2b-9b2c-556b3010ae12.

² Vt lähemalt www.tlu.ee/et/opingud/Oppeinfo/ELU.

- Drinka, T., Clark, P.** (2000). *Health Care Teamwork: Interdisciplinary Practice and Teaching*. Westport, CT: Auburn House.
- Edwards, C.** (2002). A proposal that patients be considered honorary members of the health-care team. *Journal of Clinical Nursing*, 11, 340–348.
- Freidman, D., Berger, D.** (2004). Improving team structure and communication a key to hospital efficiency. *Archives of Surgery*, 139, 1194–1198.
- Gittell, J., Fairfield, K., Bierbaum, B., Head, W., Jackson, R. Kelly, M., Laskin, R., Lipson, S., Silinski, J., Thorhill, T., Zuckermann, J.** (2000). Impact on relational coordination on quality of care, postoperative pain and functioning, and length of stay: a nine-hospital study of surgical patients. *Medical Care*, 38, 807–819.
- Goldman, J., Bhattacharyya, O., Zwarenstein, M., Reeves, S.** (2009). Improving the clarity of the interprofessional field: implications for research and continuing interprofessional education. *Journal of Continuing Education of the Health Professions*, 29, 151–156.
- Grobler, L., Marais, B., Mubunda, S., Marindi, P., Reuter, H., Volmink, J.** (2009). Interventions for increasing the proportion of health professionals practising in rural and other underserved areas. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (1): CD005314.
- Hammick, M., Freeth, D., Koppel, I., Reeves, S., Barr, H.** (2007). A best evidence systematic review of interprofessional education. *Medical Teacher*, 29, 735–751.
- Headrick, L., Wilcock, P., Batalden, P.** (1998). Interprofessional working and continuing medical education. *BMJ*, 316, 771–774.
- IFSW.** (2014). *Global Definition of Social Work*. International Federation of Social Workers.
- Ignatavičius, D., Hausman, K.** (1995). *Clinical Pathways for Collaborative Practice*. Philadelphia: W.B. Saunders Company.
- Kutsekoda.** (2014). Kutsestandard: Sotsiaaltöötaja: tase 6, tase 7. www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid (05.09.2017).
- Hooker, R., McCaig, L.** (2001). Use of physician assistants and nurse practitioners in primary care, 1995–1999. *Health Affairs*, 20, 231–238.
- Jelphs, K., Dickinson, H.** (2008). *Working in Teams*. Bristol: Policy Press.
- Leathard, A.** (2003a). Introduction. Teoses: Leathard, A. (toim.) *Interprofessional Collaboration: From Policy to Practice in Health and Social Care*. Hove: Brunner-Routledge.
- Leathard, A.** (2003b). Conclusion. Teoses: Leathard, A. (ed) *Interprofessional Collaboration: From Policy to Practice in Health and Social Care*. Hove: Brunner-Routledge.
- Lewin, S., Skea, Z., Entwistle, V., Zwarenstein, M., Dick, J.** (2001). Interventions for providers to promote a patient-centred approach in clinical consultations. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4): CD003267.
- McPherson, K., Headrick, L., Moss, F.** (2001). Working and learning together: good quality care depends on it, but how can we achieve it? *Quality in Health Care*, 10 (SII), 46–53.
- Newman, J., Vidler, E.** (2006). Discriminating customers, responsible patients, empowered users: consumerism and the modernisation of health care. *Journal of Social Policy*, 35, 193–209.
- Onyett, S.** (2003). *Teamworking in Mental Health*. Basingstoke: Palgrave.
- Overtveit, J.** (1997). Planning and managing teams. *Health and Social Care in the Community*, 5, 269–276.
- Piquette, D., Reeves, S., LeBanc, V.** (2009). Interprofessional intensive care unit team interactions and medical crises: a qualitative study. *Critical Care Medicine*, 37, 1251–1255.
- Pritchard, P.** (1995). Learning to work effectively in teams. Teoses: Owens, P., Carrier, J., Horder, J. (toim.) *Interprofessional Issues in Community and Primary Health Care*. Basingstoke: Macmillan.
- Reeves, S., Freeth, D.** (2003). New forms of information technology, new forms of collaboration? Teoses: Leathard, A. (toim.) *Interprofessional Collaboration: From Policy to Practice in Health and Social Care*. London: Routledge.

- Reeves, S., Freeth, D., Leiba, T., Glen, S., Herzberg, J. (2006). Delivering practice-based interprofessional education to community mental health teams: understanding some key lessons. *Nurse Education in Practice*, 6, 246–253.
- Reeves, S. Goldman, J. Zwarenstein, M. (2009). An emerging framework for understanding the nature of interprofessional interventions. *Journal of Interprofessional Care* 23, 539–542.
- Reeves, S., Lewin, S., Espin, S., Zwarenstein, M. (2010). *Interprofessional Teamwork for Health and Social Care*. Wiley-Balckwell.
- Reeves, S. Zwarenstein, M., Goldman, J., Barr, H., Freeth, D., Hammick, M., Koppel, I. (2008). Interprofessional education: effects on professional practice and health care outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*; (1): CD002213.
- Saia, K., Toros, K., DiNitto, D.M., Leino, M., Sindi, I., Tersteegen, E. (2017). Juvenile offender rehabilitation in Estonia: interprofessional collaboration in written assessments and specialists' perceptions. *European Journal of Social Work*.
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2017.1357022 (05.09.2017).
- Sinclair, S. (1997). *Making Doctors: An Institutional Apprenticeship*. Berg, Oxford.
- Sunstrom, E., de Meuse, K., Futrell, D. (1990). Work teams: applications and effectiveness. *American Psychologist*, 45, 120–133.
- Zwarenstein, M., Goldman, J., Reeves, S. (2009). Interprofessional collaboration: effects of practice-based interventions on professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (3): CD000072.
- Weingart, S., Simchowitz, B., Kahlert, E. T, Morway, L, Spencer, J., Zhu, J., Cleary, C., Korman-Parra, J., Horvath, K. (2009). The You CAN campaign: teamwork training for patients and families in ambulatory oncology. *Joint Commission Journal for Quality and Patient Safety*, 35, 63–71.
- West, M., Slater, J. (1996). *Handbook of Work Group Psychology*. Wiley, Chichester.
- West, M., Markiewicz, L. (2004). *Building Team-based Working: A Practical Guide to Organisational Transformation*. British Psychology Society. Blackwell, London.
- WHO. (2005). *Preparing a Healthcare Workforce for the 21st Century. The Challenge for Chronic Conditions*. Geneva: WHO.
- WHO. (2010). *Framework for action on interprofessional education and collaborative practice*. Health Professions Networks / Nursing & Midwifery / Human Resources for Health (WHO/HRH/HPN/10.3), Geneva: WHO. www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/ (05.09.2017).